

NEUROLOGIE

Dr.KHERBA_N

NEUROLOGIE

Attaque de panique

AVC

Coma

Convulsion

Crise d'épilepsie

Crise de Migraine

DNV

Fourmillements

Hernie discale

HIC

Méningite

Neuropathie diabétique périphérique

Névralgie

Paralysie faciale périphérique

Paresthésie

Tremblement

Vertiges aigues

Attaque de panique

● Clinique :

■ Sensation de peur intense, brutale et transitoire. ■ Sueurs, palpitations, impression d'étouffer, douleurs à la poitrine, nausées, picotements..

■ Rechercher : Hypoglycémie, IDM, Hyperthyroïdie, Anémie, HTA

✓ CAT :

■ Repos/VVP/Scope/SaO₂

■ O₂ thérapie

■ Dextro/TA

■ ECG

- Bilan : 
- FNS
- TSH
- Vit D
- Glycémie à jeûne

Mg 1 amp dans 250cc SG5% en IVL
+/_ Primperan en IM (effet sédatif)

 Traitement de sortie :

- Magnol stress cp 1cp/j

AVC

● Clinique :

- Troubles neurologiques : aphasie, dysarthrie, céphalée (drapeau rouge), flou visuel, paralysie faciale périphérique ou centrale, déficit moteur, hémiparésie ou hémiplégie.
- Diagnostic différentiel : Crise épileptique => perte des urines, morsure de la langue..

✓ CAT :

- O₂/VVP
- Dextro/T°
- TA > 18/10 ne pas ↘ TA avant faire une TDM
- Sauf si TA 220/120 on ↘ progressivement
- ECG pour éliminer IDM

☞ Evacuation pour un scanner cérébral

20% : hyperdensité=> AVC hémorragique

☞ Evacuation Neurochirurgie

80% : hypodensité => AVC ischémique

☞ Hospitalisation au moins 24_48h

- Si TDM normale a refaire 48_72h

- Mannitol 100cc/8h

⊖ SGI est CI risque d'œdème cérébral

- Matelas antiescarres

- O2 : 3l/min sauf si SaO2 correcte

- Réhydratation SSI/8h 1flc

- Si fièvre : Perfalgan/8h 1flc

- Si Gly >2g : Insulinothérapie 10UI en Sc

- Arrêter l'alimentation orale pas avant 2j

- Si hypoK : 1g KCl

- Si hypoNa : 3g NaCl 1g/flc

- Si risque d'infection nosocomiale traitement préventif : Claforan 1g/12h ou Augmentin 1g/12h

- Si TA >220/120=>1cc Loxen dilué SG5%

Ou Loxen à la SAP 1cc/h, réajuster toutes les 30mn

- ECG : si Troubles de rythme  Avis cardiologie

- Sonde urinaire

 Traitement :

- SOMAZINA (Neuroprotecteur) amp 500mg en IVL 250cc SSI 1amp/j

Relais per os 40gtt/min 3_5ml 2_3/j pdt 6mois_2ans

Ou 400mg/j 2ml 3/j

- Aspegic 300mg/j pdt 48h (3cp de 100mg en une seule prise à heure fixe), puis 100mg/j 1st/j

- Atrovastatine 40mg

- Lovenox 0.4/j

■ Contrôle TDM après 48h

■ Bilan : 

■ FNS/Gly

■ Urée/Créat

■ CT/TG

■ TP

■ Hépatique

■ Lipidique

■ TSH

■ Ionogramme

■ Consulter  Cardio/Neuro/Kinésithérapie

Coma

 En urgence :

PLS/O2/Perfusion SSI

TA/T°/VVP/Dextro

■ Bilan : 

■ FNS/Gly

■ Urée/Créat

■ ASAT/ALAT

■ CPK

■ ECG

■ Ionogramme

■ Si : Traumatisme :

■ Signes de focalisation  Avis neurologie

■ Pas de signes de focalisation=> TDM

- Si : pas Traumatisme :
- CO=> O2 : 8l/min
- Médicaments=> O2 + 100mg HHC en IV
- Hypoglycémie=> 50cc SG30%

Puis 1flc SG10% puis 1flc SG5% 1flc/8h

- Restauration de conscience => alimentation (glucides/lipides) pour éviter les rechutes

⊖ Devant tout coma, il faut évoquer l'hypoglycémie comme cause (l'étiologie la plus fréquente)

Enfant/Adulte		
Activité	Score	Description
Ouverture des yeux	4	Spontanée
	3	À la demande
	2	À la douleur
	1	Aucune
Réponse verbale	5	Orientée
	4	Confuse
	3	Paroles inappropriées
	2	Sons incompréhensibles
	1	Aucune
Réponse motrice	6	Obéit aux commandes
	5	Localise à la douleur
	4	Retrait à la douleur
	3	Flexion anormale (décortication)
	2	Extension anormale (décérébration)
	1	Aucune

Convulsion

● Clinique :

- Interrogatoire : grossesse, allaitement, vaccin, VIH, épilepsie, néoplasie, traumatisme, éthylisme, médicaments (diurétiques..), hypoglycémie, méningite, AVC..
- Si 1^{ère} crise => TDM/EEG/ECG
- Convulsion + Fièvre => TDM + PL
- Convulsion + Confusion >24h=> Hospitalisation + TDM + EEG
- Intoxication médicamenteuse=> Dosage

✓ CAT :

- PLS/O2 thérapie
- TA/Dextro

- Valium 0.5mg/kg (poids/2) 1 amp 10mg (2cc) dans 10 cc de SSI 9% en IVL sans dépasser 2amp (max 1amp 10cc)

- Si pas de réponse après 20min :

2^{ème} amp Valium

- Gardenal dose de charge 15mg/kg sur 2 fois dans 500cc de SG à flot en 30_45min

- Si réponse :

Dose d'entretien 160mg 5mg/kg dans 500cc SG gtt à gtt passer en 24h, sans dépasser 1g

- État de mal convulsif :

- Valium 1amp diluée Ou 0.1mg/kg/j en IVL

- Gardenal 10mg/kg/j

- Bilan : 
- FNS/Gly
- VS/CRP
- Ionogramme
- Calcémie
- Natrémie
- Mg

■ Enfant 🍼.

■ PLS/O₂ : 4L/min si masque 8L/min

■ Dextro/T°/VVP

■ Valium 0.5mg/kg en intra rectale IR

Max : 10mg/j et 5mg/j chez le nourrisson

■ Si pas réponse après 5min :

2^{ème} Valium 0.5mg/kg en IR

3^{ème} Valium 0.5mg/kg en IR

■ A renouveler chaque 10min

Si non en IV max 1.5mg/kg/j dilué dans 3cc de SSI

■ Si pas de réponse :

■ Gardenal 2mg/kg/j Max 20mg

Dans 150mg SG5% ou 60cc SSI en IVL 20min

- Gardenal à répéter 4× si pas de réponse :
 - 20mg/kg=> NNE
 - 15mg/kg=> NRS
 - 10mg/kg=> Enfant
-
- Toujours dilué dans 60cc de SSI en IVL en 20min
 - À renouveler 10mg/kg chaque 10min sans dépasser 40/kg/j
-
- Puis 1 dose d'entretien 3_5mg/kg/j à 12h Après dose de charge
-
- Rivotril 0.05 à 0.1mg/kg/j en perf continue de SSI

- Bilan : 
 - Gly
 - Ionogramme
 - Ca/Mg
 - FO
 - TDM
 - Fièvre :
 - Foyer si infection : Augmentin 1ddp 2/j
 - Pas de foyer : TLT + ECBU
 - Si ECBU(+) => Oroken 1ddp 2/j pdt 7j
 - Si traumatisme => Scanner
 - Si apyrétique + crises  Avis neurologie
- Depakine 10mg/kg/j pdt 5_7j
- En attendant la consultation neurologie
- Si Pyrétique : PL + EEG
 - Si crises complexes TDM ou IRM
 - Si 1^{ère} épisode => PL

⊖ Valium est CI chez nouveau_né <2mois

Et en cas d'insuffisance respiratoire =>

Gardenal

Crise d'Épilepsie

● Clinique :

Perte de connaissance entraînant une chute, des convulsions, l'apparition de salive au bord des lèvres, vomissements, perte d'urine ou de selles, un bref arrêt de la respiration..

✓ Traitement :

- Adulte : Valium 1amp en IVD
- Enfant : Poids/2mg Valium en IR sans dépasser 1amp
- À renouveler après 10min si pas d'amélioration

Crise de Migraine

● Clinique :.

Douleur unitemporale pulsatile

🏠 En urgence :

O2 : 5_10min

Perfalgan 1flc en IVD

Primperan 1amp en IM

Ou Voltarene 1amp en IM

✓ Traitement de sortie :

1 Voltarene cp 50mg 1cp 2/j au milieu de repas

2 Dolyc cp 500mg 1cp 2/j

3 Si signes digestifs : Mitoclopramide 1cp 2/j
15min avant repas

✓ Traitement de fond :

Migrazan cp 1cp 3/j pdt 1mois et demi

Ou Migrex 50mg 1cp/j

Ou Sunmigran cp 1cp 3/j

Ou Laroxyl gtt 4_10gtt/j soir pdt 1_3mois

Ou Seglor gtt/gel 30gtt ou 1gel 3/j pdt 3mois

Ou Triptan (Relpax) 2cp 2/j ou 1cp à la demande
(au début de crise)

+ Bétabloquant ½ cp Neocardil (Propranolol)
3_5j max

■ Si Traitement inefficace → Avis neurologie

■ Femme enceinte 

Perfalgan

Solumedrol 40mg en IM

+/_ Mg

Dyctocie neurovégétative DNV

● Clinique :

Trouble du passage de l'excitation nerveuse au niveau du nerf vague

Fatigue intense, soif excessive (polydipsie), vertige, anxiété, panique, palpitations lentes..

✓ CAT:

- O2 thérapie

- Primperan 1amp en IM (effet sédatif)

Ou Primperan 1amp dans 250cc SSI

Ou Primperan 1/2amp diluée en IVD

Ou Phenergan IM ou IVL

- Mg 1amp diluée dans 250cc SG5% IVL

- Si HTA... on traite cas par cas..

■ Prise des constantes si : normal libérer le malade avec :

Mg cp/sirop/inj

1cp le soir

Isomag sirop 1_2càs/j

Ou Cacipronat

■ Bilan : 

■ FNS

■ TSH

■ Glycémie à jeûne

■ Ca

■ Mg

Fourmillements

● Clinique:

Rechercher une prise des médicaments

Éliminer un AVC, syndrome de canal carpien, arthrose ou hernie cervicale..

Cervicobrachialgies=> Radio du rachis cervicale

- Prise de TA

- Bilan: 

- FNS

- Gly à jeûn/HBA1C

- Lipidique

- Rénal

- Ionogramme

- TSH

- Vit D
- B12/B9
- Mg
- Ca
- +/- Électrophorèse des protéines: Myélome
- ENMG

✓ CAT:

- Neurovit B1B6 cp 2cp/j pdt 10j + Mg

Ou Polyvitamines

Hernie discale

✓ CAT :

- Perfalgan 1flc en perfusion
- Voltarene 1amp en IM

✓ Traitement de sortie :

- Repos/Rééducation

→ Avis neurochirurgie

1 Profinid cp 100mg 1cp 2/j

Ou Celecoxib cp 200mg 1cp 2/j

2 Voltarene gel 1_2app/j

3 Mydocalm cp 150mg 1cp 2/j après repas

4 Codoliprane cp 1cp 2/j

5 IPP

■ Mydocalm CI :

■ Grossesse

■ Allaitement

■ Myasthénie

■ Cardiopathie

■ Hypertendu

■ Diabétique

Myoxydol= AINS + Myorelaxant

Hypertension intracrânienne HIC

● Clinique:

- Céphalées matinales en casque, ↗ par la toux, effort de défécation, résistantes aux antalgiques.
- Vomissements en jet ou en fusée, soulageant les céphalées
- Flou visuel, œdème papillaire.
- Troubles de vigilance
- HTA, bradycardie
- Enfant: douleurs abdominales
- NRS: Macrocrânie, yeux en coucher de soleil, FO normal

⊖ Ponction lombaire est CI

→ TDM cérébrale

- Bilan sanguin

✓ CAT:

- Position demi assise
- Mannitol
- CTC

Méningite

● Clinique :

- Fièvre, vomissements en jet, cri aiguë, refus alimentation, crises convulsives..=> PL
 - Syndrome infectieux + syndrome méningé (Vomissements/photophobie/céphalée)
 - Raideur de la nuque, signe de Kering et Brudinski.
 - <6mois : Convulsion fébrile => PL
 - Rechercher les signes de HIC=> TDM + FO
- Avant PL

⊖ Contre indications du PL :

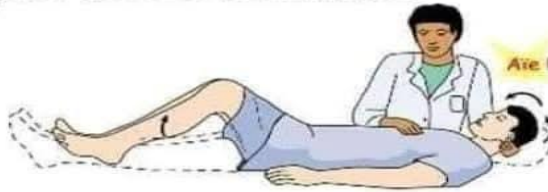
- HIC
- Troubles d'hémostase
- Instabilité hémodynamique et respiratoire.

- PL avant tout ATB sauf si :
- Purpura fulminant
- CI à la réalisation de PL
- Forte suspicion de méningite bactérienne et PEC hospitalière ne peut pas être réalisée dans les 90min

✓ Traitement :

Amoxicilline + C3G

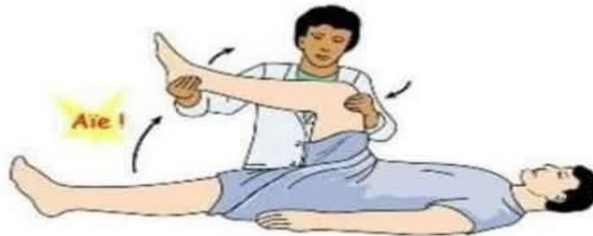
Signe de Brudzinski



La flexion antérieure de la nuque
provoque la flexion des hanches et des genoux



Signe de Kernig



Impossibilité de fléchir à angle droit
les membres inférieurs sur le tronc
sans provoquer une vive douleur lombaire
et une flexion des genoux



« Contre-Kernig » : impossibilité de s'asseoir jambes tendues

Neuropathie diabétique périphérique

- Diagnostic clinique ++

Troubles sensitifs "en chaussettes" avec ☐ des ROTS

- ENMG
- Echodoppler (éliminer une TVP)

☒ CAT:

- Confirmer le diagnostic
- Optimiser le contrôle glycémique
- Traiter les douleurs
- Neurovit B1B6B12
- Surveiller pour prévenir les complications

Névralgie

● Clinique :

Douleur intense, aiguë ou chronique, localisée au niveau d'un nerf.

✓ Traitement :

- Soulager la douleur par AINS ou CTC
- Collier cervicale => Rééducation
- Si non => Chirurgie

Paralysie faciale périphérique

● Clinique :

Touche l'hémiface, impossibilité de fermer les yeux (risque de kératite favorisée par la sécheresse), gonflement de bouche, effacement des rides, pli nasolabial, déviation de bouche.

Post infectieuse+++

- Si centrale (touche l'étage inférieure, déviation de bouche) ou déficit neuro associé => TDM (masse cérébrale)
- Si fièvre : pas de foyer => TDM=> PL
- Si TA ↗ => TDM

 En urgence :

■ TA/T°/Dextro

■ Solumedrol 40mg en IVD Ou IM

Ou HHC 100mg en IVD

Ou Dexa 12mg en IM

✓ Traitement de sortie :

1 Solupred cp 20mg le matin pdt 10j 1mg/kg/j

2cp/j pdt 5j puis 1cp/j pdt 5j

2 Dacryosérum gtt 1gtt 2/j

3 Siccafluid gtt 1gtt 3_4/j

4 Neurovit B1B6 1cp 2/j

5 Pansement oculaire 1/j + massage

■ Enfant 🧒 :

1 Neurovit cp 1cp 2/j

2 Pansement oculaire 1/j

3 Larmes artificielles (Siccafluid) gtt 1gtt 3/j

Paresthésie

- Dextro/TA
- Bilan : 
- FNS
- Vit D
- Vit B12
- Ionogramme
- Ca
- Mg
- ECG
- +/- Echodoppler ou ENMG des membres inférieurs
- Si non :  Avis neurologie

Tremblement

● Clinique:

Mouvements anormaux involontaires, rythmiques et oscillatoires, de faible amplitude..

- Examen neurologique+++

- Bilan: 

- FNS

- Gly à jeûne

- TSH/T4

- Vit D3

- Vit B12

- Ca / Mg

- PTH

Vertiges aigues

● Clinique :

- Périphérique : vertige intense, déclenché ou aggravé par les mouvements de la tête, tendance à diminuer avec le temps grâce à la compensation vestibulaire, nystagmus horizontal ou horizontal rotatoire plus intense diminue en cas de fixation de regard
- Nausées vomissements importants et acouphène sinon hypoacousie (sans signe neurologique notable)
- Centrale : sensation de déséquilibre non influencé par les mouvements de la tête, persistant dans le temps, nystagmus vertical ou multidirectionnel et moins intense, signe neurologique associés : dysarthrie, ataxie, diplopie, faiblesse musculaire et surtout les céphalées +++

Possible art des nerfs crâniens +++

CAT:

- O2/Dextro/TA/T°
- Tanganil 1amp 500mg IVD ou en perfusion
1amp de 500mg en 200cc de SG5% ou SSI en
IVL 15_30min
- 2amp/24h
- Primperan 1amp diluée en IV ou IM

- TA ↗ risque AVC => TDM
- T° pas de foyer => TDM
- Céphalée + => TDM

- Bilan : 
- FNS/Gly/HbA1C
- TSH/T4
- Urée/Créat
- Hépatique
- CT/TG

- Uricémie
- Ionogramme
- B9
- Vit D
- ECG
- Si signes de focalisation ☐ Avis neurologie

☒ Traitement de sortie :

☐ 1 Tanganil cp 500mg 1cp 3_5/j pdt 5j

☐ 2 Si Vomissements : Primperan cp 1cp 2/j
15min avant repas

☐ 1 Betaserc cp 24mg 1cp 2/j pdt 1mois

☐ 2 Domperidone cp 1cp 2/j

